



TEMÁTICA: PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER
PROFESSORA: DANIELE MATOS DE MOURA BRASIL

SAÚDE DA MULHER	CARACTERÍSTICAS
ASPECTOS GERAIS	A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as desigualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais frequentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos.
EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares EXISTIA A NECESSIDADE DE SURTIR ALGO MAIS AMPLO!
PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER	Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de prioridades neste campo (BRASIL, 1984). O PAISM incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). O novo programa para a saúde da mulher incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres (BRASIL, 1984) MAS AINDA EXISTE A NECESSIDADE DE ALGO MAIS AMPLO, COMO UMA POLÍTICA!
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER (PNAISM /2004)	A PNAISM tem como premissa o direito à saúde e o respeito às diretrizes do SUS e se baseou nas seguintes questões para a sua elaboração: • Conceituar as ações de saúde da mulher como política e não mais como programa, por entender que, conceitualmente, o termo política é mais abrangente que o termo programa, para ressaltar a resposta governamental a determinados problemas de saúde de certos grupos específicos, neste caso as mulheres; • Introduzir e visibilizar novas “necessidades” de saúde das mulheres, até então ausentes das políticas públicas; • Introduzir ações para segmentos da população feminina, todavia sem visibilidade social;



	• Definir fontes de recursos e responsabilidades nos diversos níveis do sistema, de acordo com as diretrizes do SUS e os instrumentos de gestão adotados pelo Ministério da Saúde; • Introduzir nas políticas a transversalidade de gênero, o recorte racial-étnico e as especificidades das mulheres que fazem sexo com mulheres
OBJETIVOS GERAIS	• Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro. • Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. • Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1 Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras de infecção pelo HIV e outras DST. 2 Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento reprodutivo para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde. 3 Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes. 4 Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. 5 Promover, conjuntamente com o Departamento Nacional de DST/Aids, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/Aids na população feminina. 6 Reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina. 7 Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero. 8 Implantar e implementar a atenção à saúde da mulheres no climatério. 9 Promover a atenção à saúde das mulheres idosas. 10 Promover a atenção à saúde das mulheres negras. 11 Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade. 12 Promover a atenção à saúde das mulheres indígenas. 13 Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão. 14 Fortalecer a participação e o controle sociais na definição e implementação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres

DIRECIONAMENTOS CLÍNICOS

1. MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Se o conceito de **CONCEPÇÃO** em saúde reprodutiva está ligado com o ato de gerar uma nova vida, métodos contraceptivos entram para prevenir a ocorrência dessa ação. O gráfico abaixo traz as suas categorias. São elas:



MÉTODOS COMPORTAMENTAIS

Quando falamos de **PERCEBER QUANDO OVULAÇÃO OCORRE**, entram os métodos contraceptivos COMPORTAMENTAIS. Possuem base na PERCEPÇÃO DA FERTILIDADE. Para isso, torna-se necessário que a mulher aprenda a reconhecer o início e o fim de sua janela fértil, além da responsabilidade compartilhada com seu parceiro, características pelas quais são também conhecidos como métodos comportamentais de abstinência periódica ou naturais. São métodos de BAIXO CUSTO

MODALIDADES:

- **DIAS DO CICLO MENSTRUAL:** Método rítmico do calendário (tabelinha ou Ogino-Knaus)
- **SINAIS DE FERTILIDADE:** Secreções vaginais: método da ovulação (também conhecido como método de Billings) e Temperatura corporal basal
- **CALENDÁRIO E SINAIS:** Sintotérmico

- MÉTODO RÍTMICO DO CALENDÁRIO

- Registrar ciclo menstrual POR PELO MENOS, SEIS MESES



- Início do ciclo menstrual: Dia 1 da menstruação
- Final do ciclo menstrual: Último dia antes da menstruação seguinte.
- Dessa forma ela tem a avaliação da DURAÇÃO
- A mulher subtrai 18 da duração do seu ciclo mais curto, estimando, assim, o primeiro dia de seu período fértil.
- Também deve subtrair 11 do seu ciclo mais longo, que corresponde ao último dia de seu período fértil
- Exemplo: se o ciclo menstrual variou entre 26 e 32 dias durante o registro: Ciclo mais curto: $26 - 18 = 8$. A mulher deve evitar relações sexuais sem proteção a partir do 8º dia de cada ciclo (o dia 8 é o primeiro dia de abstinência). Ciclo mais longo: $32 - 11 = 21$. Ela pode ter relações sexuais sem proteção a partir do 22º de cada ciclo (o dia 21 é o último dia fértil). Portanto, o casal não deve ter relação sexual com penetração vaginal do 8º ao 21º dia do ciclo (período considerado fértil)

- MÉTODO DE BILLINGS

- Este método fundamenta-se na evolução do muco cervical no ciclo menstrual. Durante a fase estrogênica, ocorre secreção do muco cervical e, na ovulação, este muco tem características que permitem o espermatozoide sobreviver e se locomover. Ocorrendo a ovulação, o corpo lúteo secreta progesterona, inibindo a secreção cervical

Características do muco cervical:

- O muco cervical no início é escasso, opaco e viscoso, aumentando progressivamente em quantidade e tornando-se claro, transparente e elástico, como a clara de ovo crua. No dia que corresponde ao pico de estrogênio, o muco alcança o máximo dessas características, sendo conhecido como o dia ápice do muco e corresponde à máxima fertilidade
- ÁPICE: Permanecer sem penetração vaginal por três dias.
- 4º DIA APÓS O ÁPICE: O casal pode manter relações até ela perceber novamente o período úmido

- TEMPERATURA CORPORAL BASAL:

- Logo após a ovulação, a progesterona liberada pelo corpo lúteo causa elevação da temperatura corporal em 0,2 a 0,5 graus. Na maioria das mulheres isso ocorre no meio do ciclo menstrual.



- Para utilizar este método, a mulher precisa verificar sua temperatura diariamente, da mesma maneira, **no mesmo horário pela manhã, antes de sair da cama ou ingerir alimentos**. Após três dias da elevação da temperatura, o casal pode ter relações livremente. Portanto, o período de abstinência deverá ser desde o primeiro dia do ciclo menstrual até três dias após a elevação da temperatura basal

- SINTOTÉRMICO

- A identificação do período fértil e não fértil é realizada com a combinação dos métodos da temperatura basal e da ovulação

MÉTODOS DE BARREIRA

Os métodos de barreira são assim denominados por bloquear a ascensão dos espermatozoides para a cavidade uterina, impedindo a fecundação.

Exemplos

- Preservativo Masculino
- Preservativo Feminino
- Diafragma

Entre outros

- PRESERVATIVO MASCULINO

- O uso do preservativo é recomendado em todas as relações sexuais
- Proteção contra IST's e gestações
- Deve ser colocado com o pênis ereto e seco, antes da penetração vaginal
- São fatores de risco para ruptura/deslizamento: Más condições de armazenamento, embalagem danificada, manuseio incorreto, validade comprometida, tamanho inadequado, USO DE DOIS PRESERVATIVOS, entre outros.

- PRESERVATIVO FEMININO

- Consiste em um dispositivo que é inserido na vagina antes do coito com a finalidade de impedir que o pênis e o sêmen entrem em contato direto com a mucosa genital feminina.
- Deve ser usado em todas as relações sexuais, mesmo durante a menstruação
- O preservativo feminino não deve ser usado junto com o preservativo masculino porque o atrito aumenta o risco de rompimento



- Contra indicado na alergia ao látex e em prolapsos genitais

- DIAFRAGMA

- O diafragma é um dispositivo vaginal de anticoncepção, que consiste em um capuz macio de borracha, côncavo, com borda flexível, que cobre parte da parede vaginal anterior e o colo uterino.
- Servem como uma barreira mecânica à ascensão do espermatozoide da vagina para o útero.
- É necessária a medição por profissional de saúde treinado, para determinar o tamanho adequado a cada mulher. O prazo de validade do diafragma é em média de cinco anos.
- Contra indicado no contexto do HIV/AIDS

LACTÂNCIA COM AMENORRÉIA

- Este método fundamenta-se na hiperprolactinemia existente em resposta ao estímulo da sucção durante a amamentação e, conseqüentemente, níveis de FSH e de LH insuficientes para estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos.

CRITÉRIOS:

1. O bebê deve ter até os SEIS MESES de vida;
2. A nutriz deve estar em AMENORREIA; e
3. O ALEITAMENTO deve ser EXCLUSIVO (dia e noite) ou quase.

IMPORTANTE: a ausência de um destes critérios descaracteriza o AM como método contraceptivo.

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

O dispositivo intrauterino consiste em um objeto sólido de formato variável que é inserido através do colo uterino na cavidade uterina, com o objetivo de evitar a gestação. Pode ser de cobre ou hormonal.

COBRE

- Depende de uma reação de corpo estranho para sua ação contraceptiva, trata-se de reação inflamatória estéril que produz lesão tecidual mínima, porém suficiente para ser espermicida



- A presença de um corpo estranho e de cobre na cavidade endometrial causa mudanças bioquímicas e morfológicas no endométrio, além de produzir modificações no muco cervicais
- O cobre é responsável pelo aumento da produção de prostaglandinas e pela inibição de enzimas endometriais. Estas mudanças **afetam adversamente o transporte de espermatozoides, de modo a prevenir a fertilização.** Os íons de cobre também têm um efeito direto na motilidade espermática, **reduzindo a capacidade de penetração no muco cervical**
- Pode ser considerado **para qualquer mulher que esteja procurando por um método contraceptivo de confiança, reversível, independente do coito, de longo prazo.** As mulheres que têm contraindicações ao estrogênio ou mulheres que amamentam podem ser boas candidatas para o uso dos DIUS

INDICAÇÕES

- **Adultos Jovens e Adolescentes:** Este método pode ser utilizado por mulheres jovens e adolescentes, se selecionadas cuidadosamente, principalmente se estiverem em relações monogâmicas mútuas e estáveis e, portanto, com baixo risco para DSTs
- **Nulíparas:** As mulheres nulíparas que necessitam ou desejam métodos contraceptivos não hormonais podem beneficiar-se de um DIU de cobre de tamanho menor, porém ainda pouco estudado. A expulsão é mais comum entre as nulíparas
- **Pós Parto:** Mulheres pós-parto podem ser candidatas à inserção imediata (dentro de 15 minutos depois da dequitação da placenta) Na maioria dos casos, é melhor inserir o DIU após a completa involução uterina, normalmente de **quatro a seis semanas pós-parto**

MÉTODOS HORMONAIS

Nome	Composição / Como iniciar?	O que faz?	Contraindicações	O que fazer se esquecer
Anticoncepcional ORAL combinado	Estrógeno e Progesterona Iniciar entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual. Pausa entre as cartelas	Impedem a ovulação: Inibem o pico do LH. Mudança do muco cervical	• Amamentação • Enxaqueca com aura • CA de mama atual • História atual de TVP • AVC prévio ou atual	1P: Tomar imediatamente 1 ou 2P: Imediato e a seguinte no horário regular 3P: Imediato e método de barreira por 7d



Minipílula (ORAL)	Progesterona. Ingerir 1 comprimido ao dia sem intervalo entre as cartelas	Espessamento do muco, redução da motilidade tubária, inibe proliferação endometrial	CA de mama atual	Tomar uma pílula assim que possível; continuar tomando diariamente uma pílula ao dia; abster-se de atividade sexual ou usar proteção contraceptiva adicional nos dois próximos dias
Injetável Mensal	Estrógeno e Progesterona A cada 30 dias. Pode ser adiantado ou atrasado em até 7 dias	Impedem a ovulação: Inibem o pico do LH. Mudança do muco cervical	- Amamentação - Enxaqueca com aura - CA de mama atual - História atual de TVP - AVC prévio ou atual	Administrar. > 7 dias: Método de Barreira
Injetável Trimestral	Progesterona A cada 13 semanas. Adiantado ou atrasado em até 2 semanas	Espessamento do muco, redução da motilidade tubária, inibe proliferação endometrial e o pico de LH	CA de mama atual	Tomar a injeção independente do atraso. >2s: Método de Barreira

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGENCIA

A contracepção de emergência (CE) refere-se aos métodos que podem ser utilizados por mulheres nos dias após um intercurso sexual desprotegido e que poderia ocasionar a elas uma gestação indesejada.

- Método de Yuzpe: Regime contraceptivo combinado que consiste na ingestão de duas doses de 100 mcg de etinilestradiol e 500 mcg de levonorgestrel em duas tomadas; com intervalo de 12 horas; sendo a primeira tomada a mais próxima possível da atividade sexual desprotegida e, preferencialmente, no máximo após 72 horas deste
- Contraceptivo com levonorgestrel isolado: Usa-se o levonorgestrel na dose de 1,5 mg em dose única ou fracionada em duas tomadas, com intervalo de 12



horas. Uma dose única de levonorgestrel é tão eficaz quanto à dose fracionada e mostra-se mais conveniente à paciente, sem aumentar os efeitos adversos. Esclarecer os mecanismos de ação que levam aos efeitos anticoncepcionais da contracepção de emergência (CE) é fundamental para desconstruir o mito do “efeito abortivo” divulgado por segmentos religiosos. O mecanismo de ação varia de acordo com o momento do ciclo menstrual em que a contracepção de emergência é administrada:

- Se na primeira fase do ciclo, antes do pico do LH (hormônio luteinizante), a CE altera o crescimento folicular, impedindo ou retardando a ovulação por muitos dias. A ovulação é impedida ou adiada em 85% dos casos; não havendo contato dos gametas feminino e masculino.
- Se administrado na segunda fase do ciclo menstrual, após ocorrida a ovulação, a CE atua por meio destes mecanismos para impedir a fecundação: Alteração do transporte dos espermatozoides e do óvulo pelas tubas uterinas, modificando o muco cervical tornando-o hostil à espermomigração e interferindo na capacitação espermática. Não há qualquer evidência científica de que a CE exerça efeitos após a fecundação dos gametas. Não há nenhuma sustentação que a CE seja um método que resulte em aborto.

2. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

ATUAÇÃO NAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS/HIV

Saúde sexual é uma estratégia para a promoção da saúde e do desenvolvimento humano² e integra aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual, de maneiras que são positivamente enriquecedoras e que melhoram a personalidade, a comunicação, o prazer e o amor.

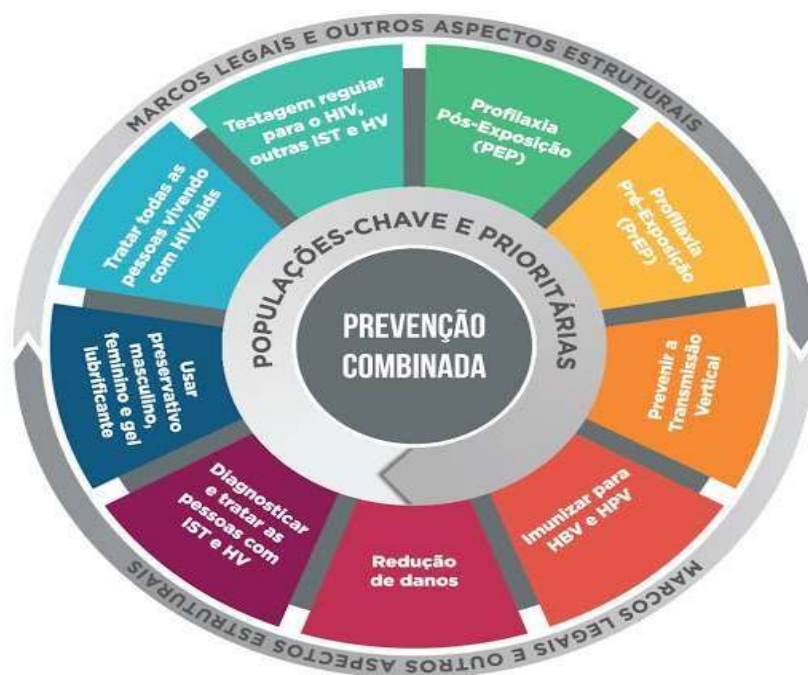
A sexualidade é definida como uma questão essencial do ser humano, que contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Pode ser vivida e expressada por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, embora nem todas essas dimensões sejam experimentadas ou expressadas.

A escuta ativa e a promoção de um ambiente favorável ao diálogo sobre as práticas sexuais devem estar presentes na rotina dos serviços de saúde. Essa abordagem

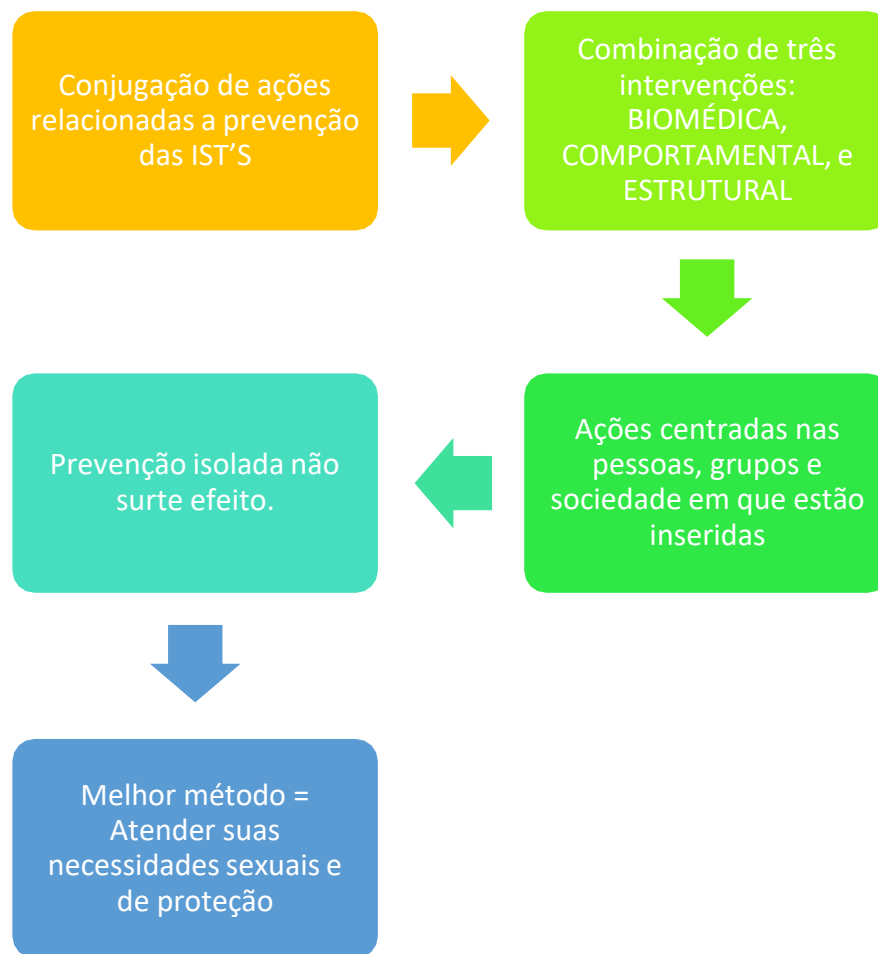


possibilita vínculos e facilita a adesão às tecnologias disponíveis ofertadas pelos profissionais de saúde. A escuta qualificada deve ser realizada com atenção e respeito, livre de preconceitos, possibilitando que a própria pessoa encontre soluções para suas questões. Considerando essa percepção e preceito, faz-se necessária uma abordagem do cuidado sexual, em que a oferta exclusiva de preservativos não é suficiente para garantir os diversos aspectos da saúde sexual. Assim, torna-se fundamental a ampliação da perspectiva para avaliação e gestão de risco, além das possibilidades que compõem a Prevenção Combinada.

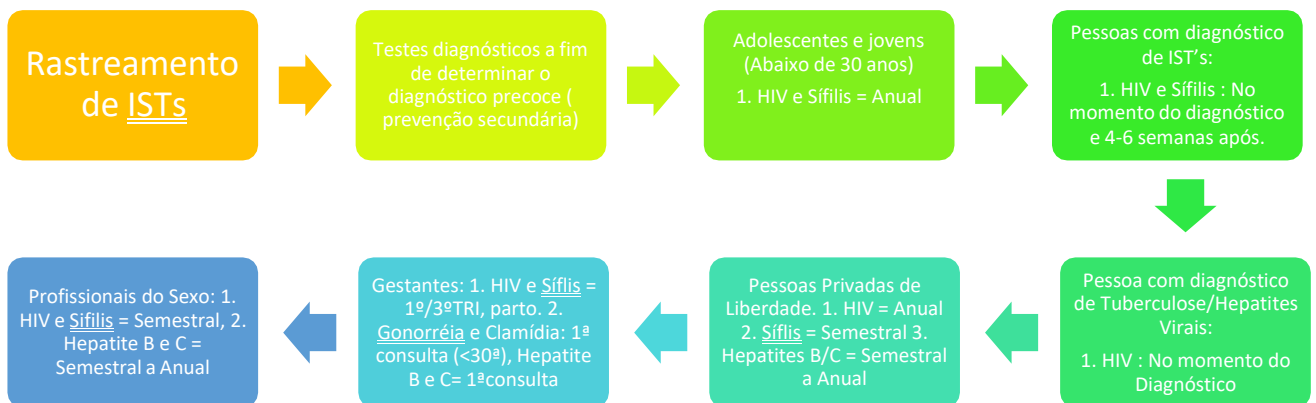
O termo “Prevenção Combinada” remete à conjugação de diferentes ações de prevenção às IST, ao HIV e às hepatites virais e seus fatores associados. Assim, sua definição está relacionada à combinação das três intervenções: biomédica, comportamental e estrutural (marcos legais), aplicadas ao âmbito individual e coletivo. A união dessas diferentes abordagens não encerra, contudo, todos os significados e possibilidades da Prevenção Combinada, conforme descrito a seguir:



Em suma, os pontos mais relevantes da abordagem inicial ao indivíduo acometido por uma IST incluem:



O rastreamento é a realização de testes diagnósticos em pessoas assintomáticas a fim de estabelecer o diagnóstico precoce (prevenção secundária), com o objetivo de reduzir a morbimortalidade do agravo rastreado^{14,15}. Diferentemente de outros rastreamentos, como a mamografia para câncer de mama, o rastreamento das IST não identifica apenas uma pessoa; ao contrário, estará sempre ligado a uma rede de transmissão. Quando não identificado e tratado o agravo na(s) parceria(s), este se perpetua na comunidade e expõe o indivíduo à reinfecção, caso não se estabeleça a adesão ao uso de preservativos. Para o restante da população, o rastreio está condicionado a avaliação de risco.



IMUNIZAÇÕES

A imunização para HPV é realizada por meio de vacina quadrivalente (tipos 6, 11, 16 e 18), estando indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.

ANTES:

Duas doses, com intervalo de seis meses.

Imunossuprimidos: faixa etária indicada para imunização é de 9 a 26 anos, sendo o esquema de vacinação composto por três doses (0, 2 e 6 meses)

AGORA:

Estendida a faixa de recebimento da dose de HPV em imunossuprimidos. Agora ela atingirá HOMENS E MULHERES ATÉ AOS 45 ANOS

ATUALIZAÇÃO – VACINA HPV 2022 (<http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/vacina-hpv-quadrivalente-e-ampliada-para-homens-de-ate-45-anos-com-imunossupressao>)

Vacina HPV quadrivalente é ampliada para homens de até 45 anos com imunossupressão
Publicado:

07.07.2022 - 10:38

última modificação:

20.07.2022 - 18:30

A faixa etária para a vacinação contra o Papilomavirus humano (HPV4) na população masculina imunossuprimida foi ampliada. A partir de agora, homens de até 45 anos transplantados, pacientes oncológicos ou vivendo com HIV/aids podem se vacinar. O esquema tradicional de três doses será usado, independentemente da idade.



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que haja de 9 a 10 milhões de infectados por esse vírus no Brasil e que a cada ano surjam 700 mil novos casos de infecção. O risco de desenvolvimento de cânceres associados ao HPV é cerca de quatro vezes maior entre pessoas vivendo com HIV/Aids e transplantados do que na população sem a doença ou transplante.

A imunossupressão crônica é um dos principais fatores de risco para aquisição e persistência do HPV. Este também é um importante fator de risco para a progressão de lesões pré-cancerosas e neoplasias, especialmente em pessoas vivendo com HIV/Aids, transplantados de células tronco-hematopoiéticas e órgãos sólidos e indivíduos em tratamento para câncer (radio e/ou quimioterapia).

Quem pode se vacinar:

Meninas de 9 a 14 anos;

Meninos de 11 a 14 anos;

Homens e mulheres imunossuprimidos, de 9 a 45 anos, que vivem com HIV/aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos.

A vacina HPV quadrivalente pode prevenir os cânceres relacionados aos HPV 16 e 18; de colo do útero; vulva e vagina; câncer peniano e cânceres de orofaringe e anal em homens e mulheres, além das verrugas genitais nos dois sexos relacionadas ao HPV 6 e 11.

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis

HEPATITE B

No Brasil, desde 2016, a vacinação contra a hepatite B está indicada para todas as faixas etárias. Três doses de vacina contra a hepatite B induzem títulos protetores de anticorpos (anti-HBs maior ou igual a 10 UI/mL) em mais de 90% dos adultos e dos jovens saudáveis, e em mais de 95% dos lactentes, das crianças e dos adolescentes.

HEPATITE A

É fato que estamos diante de uma hepatite de transmissão fecal-oral. A transmissão sexual é infrequente. Porém, nos últimos anos, casos de transmissão sexual foram confirmados no Brasil e em outros países, ocasionados por outras práticas sexuais. A vacinação se constitui como a principal medida de prevenção contra a hepatite A, sendo extremamente eficaz e segura.

Lançado em 2018, a Nota Informativa nº 15/2018-COVIG/CGVP/ DCCI/SVS/MS (BRASIL, 2018e), ampliou a vacinação para pessoas que tenham a prática oral-anal, sendo tal fato iniciado em São Paulo depois de verificado o aumento de casos.

Além disso, atualmente, no SUS, a vacina para hepatite A está indicada para crianças de 15 meses a cinco anos incompletos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), e nos CRIE, para pessoas de qualquer idade que apresentem as seguintes situações: hepatopatias crônicas de qualquer etiologia



(incluindo os portadores do HCV e do HBV), coagulopatias, PVHIV, portadores de quaisquer doenças imunossupressoras ou doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, candidatos a transplante de órgãos, doadores de órgãos cadastrados em programas de transplantes e pessoas com hemoglobinopatias. Nesse contexto, toda a população HSH vivendo com HIV deve ser vacinada

PERGUNTAS ESPECÍFICAS – CONSULTAS DE ROTINA EM SAÚDE SEXUAL

1. Saúde Sexual
2. Identificação (identidade de gênero,/orientação sexual)
3. Parcerias
4. Práticas Sexuais
5. História de ISTs
6. Proteção
- 7 . Planejamento Reprodutivo

EXAMES

A anamnese, a identificação das diferentes vulnerabilidades e o exame físico são importantes elementos na abordagem das pessoas com IST. Durante o exame físico, quando indicado, procede-se à coleta de material biológico para exame laboratorial. Sempre que disponíveis, devem ser realizados exames para: › Gonorreia › Clamídia › Sífilis › HIV › Hepatite B › Hepatite C

“ VACA COGT” – SINDROME CORRIMENTO VAGINAL E URETRAL			
AGENTE ETIOLOGICO	INFECÇÃO	SINTOMAS	TRATAMENTO
Gardnerella Mobiluncus/ agentes	Vaginallis/ Mutiplos	Vaginose Bacteriana	Corrimento branco acinzentado, odor forte.
			Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 dias



<i>Candida albicans</i>	Candidíase vulvovaginal	Corrimento branco, grumoso. Prurido intenso	Miconazol creme a 2% ou outros derivados imidazólicos, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Gonorréia	Não produz corrimento. Mucopus cervical. Dor a mobilização e friabilidade	Não complicada: Ceftriaxona 500mg, IM, dose única Disseminada: Ceftriaxona 1g IM ou IV ao dia, completando ao menos 7 dias de Tratamento
<i>Chlamydia trachomatis</i> (sorovars D ao K)	Clamídia	Não produz corrimento. Mucopus cervical. Dor a mobilização e friabilidade	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Tricomoniase	Corrimento vaginal amarelo esverdeado, bolhoso, odor fétido (peixe)	Metronidazol 400mg, 5 comprimidos, VO, dose única (dose total de tratamento 2g)

“ SCHDL ” – SINDROME ULCERA ANO GENITAL



AGENTE ETIOLOGICO	INFECÇÃO	SINTOMAS	TRATAMENTO
<i>Treponema pallidum</i>	Sífilis	Primária Secundária Terciária Congênita (Precoce e Tardia – 2 anos de idade	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose unica (1,2 milhão UI em cada gluteo) • Dobro da Dose na Secundária • Neurosífilis: Cristalina e EV,
<i>Haemophilus ducreyi</i>	Cancro	Lesões dolorosas e múltiplas	Ceftriaxona 250mg, IM, dose única
Vírus do Herpes simplex (tipo 2)	Herpes	Primoinfecções e surtos. Sintomas inespecíficos/ Vesículas/ Linfoadenomegalia/ Acometimento urinário	Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 3x/dia, por 7-10 dias
<i>Klebsiella granulomatis</i>	Donovanose	Úlceras Múltiplas. Espeho	Doxiciclina 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por pelo menos 21 dias
<i>Chlamydia trachomatis</i> (sorovars L1, L2 e L3)	Linfogranuloma Venéreo	Pápula, Disseminação e sequelas (comprometimento ganglionar)	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, 1x/semana, por 21 Dias



BIBLIOGRAFIA DE APOIO

1. PNAISM:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
2. MANUAL DE ANTICONCEPÇÃO DA FEBRASGO:
<https://central3.to.gov.br/arquivo/494569/>
3. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZ TERAPEUTICA – IST 2022:
https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/view